

Rúbrica: Matriz de Tensión entre Urgencia Sintomática y Demanda de Sentido

Instrumento de evaluación clínica para psicoterapeutas · Encuadre diagnóstico y orientación de intervención

3 Criterios Clínicos

Carga alostática, investidura libidinal y estrategia de intervención

Escala de 1 a 9 puntos

Cada criterio se puntúa de 1 a 3 según el nivel observado en sesión

3 Niveles Clínicos

Bloqueo · Transición · Vitalidad Proyectiva

 Dirigido a clínicos y psicoterapeutas que trabajan con pacientes en transiciones vitales: nido vacío, crisis de mitad de vida, jubilación.

Tensión Clínica Central

La rúbrica evalúa la **tensión dinámica** entre la carga sintomática del paciente y su capacidad de orientarse hacia el sentido. Esta tensión determina el encuadre clínico óptimo y la viabilidad del trabajo proyectivo.

Polo Sintomático

Urgencia sintomática: Predominio de ansiedad o depresión reactiva a pérdidas de rol — nido vacío, crisis de mitad de vida, jubilación. El sistema de recompensa cerebral se encuentra inhibido.

Polo de Sentido

Demanda de sentido: Capacidad del sujeto de invertir libidinalmente el porvenir, formular metas y sostener curiosidad proyectiva frente a la apertura existencial.

Convergencia Clínica

El punto de equilibrio donde el síntoma puede **resignificarse como brújula** y el proyecto terapéutico se vuelve viable. Es el umbral óptimo de intervención proyectiva.

Sistema de Puntuación

3 criterios × 3 niveles = máximo 9 puntos. Cada criterio se puntúa de 1 a 3 según el nivel observado en la evaluación clínica.

Carga Alostática y Vacío Existencial

Evalúa el predominio de sintomatología ansiosa o depresiva reactiva a la pérdida de roles y la visualización del futuro como amenaza o espacio en blanco.

Nivel 1 — 1 punto

Sintomatología ansiosa/depresiva predominante. El futuro se vislumbra como amenaza o vacío insondable. Sistema de recompensa cerebral apagado. Pérdidas de rol no elaboradas.

Nivel 2 — 2 puntos

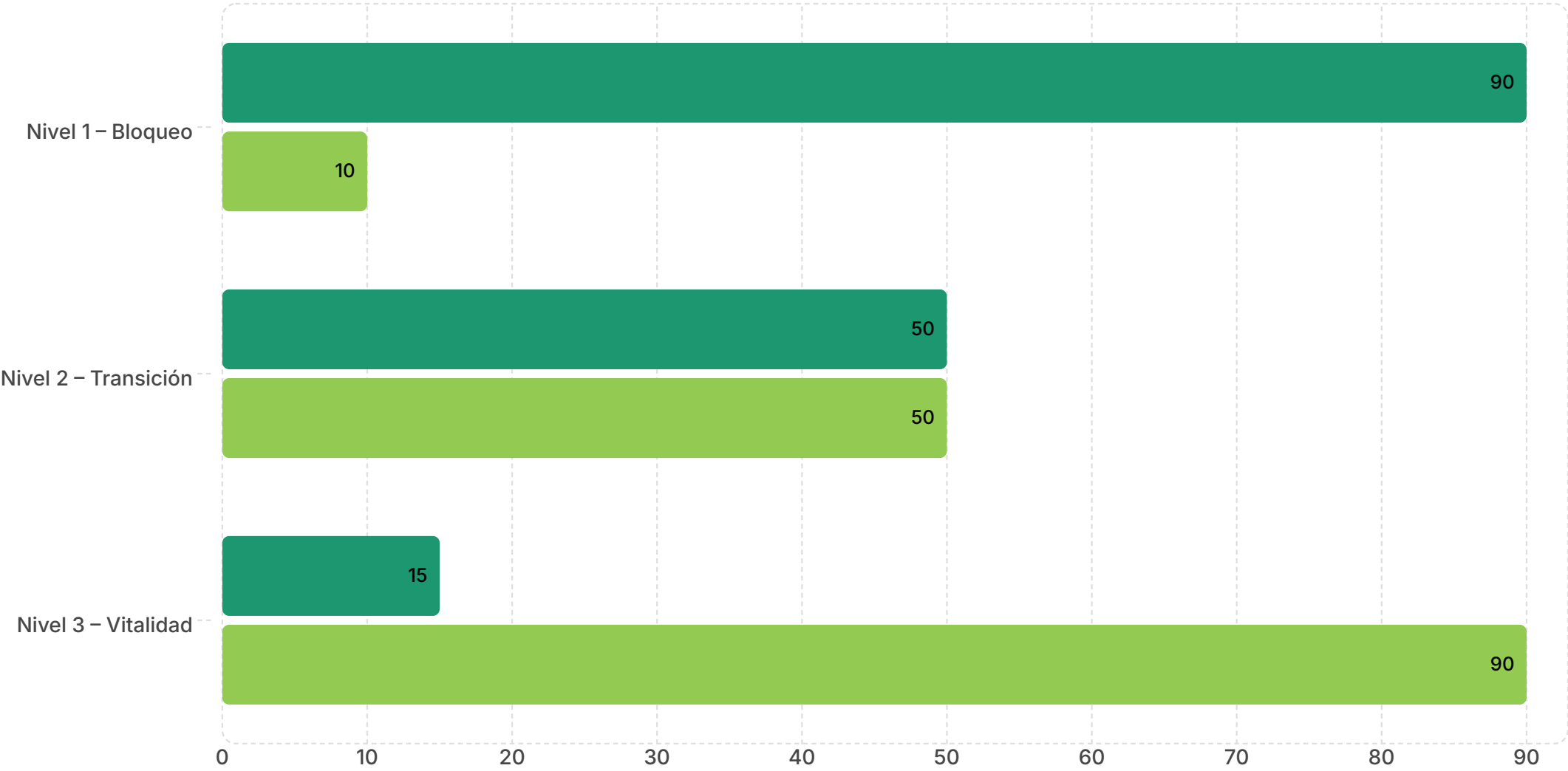
El síntoma cede parcialmente o se resignifica como señal de alarma vital. Emerge curiosidad por el porvenir, pero coexisten bloqueos cognitivos ("a mi edad ya es tarde") y hábitos arraigados.

Nivel 3 — 3 puntos

Sentido claro de legado o contribución personal. Los obstáculos son procesados como desafíos adaptativos. Redes de apoyo nutritivas activas. Ausencia de sintomatología reactiva incapacitante.

Intensidad Sintomática Capacidad Proyectiva

Nivel



La progresión clínica ideal muestra una **inversión de la relación** entre carga sintomática y capacidad proyectiva: a medida que el síntoma cede, el horizonte de sentido se amplía.

Capacidad de Inestidura Libidinal del Porvenir

Mide la posibilidad de planificar a mediano y largo plazo, y la presencia de curiosidad o vitalidad proyectiva como indicadores de disponibilidad para el trabajo de sentido.

1

Nivel 1 — 1 punto · Horizonte colapsado

Imposibilidad de planificar a mediano/largo plazo. El vaciamiento y la alta carga alostática bloquean toda formulación proyectiva. El horizonte temporal se colapsa al **presente inmediato**.

2

Nivel 2 — 2 puntos · Búsqueda incipiente

Búsqueda incipiente de propósito. El síntoma funciona como brújula pero compite con hábitos arraigados. Aparecen preguntas sobre el sentido, aunque **sin capacidad de sostener planes concretos** de largo aliento.

3

Nivel 3 — 3 puntos · Vitalidad proyectiva

Vitalidad proyectiva y trascendencia. Despliegue creativo sostenido. Capacidad de formular y sostener metas complejas orientadas a la **autoría existencial** y la autorrealización.

❏ La investidura libidinal del porvenir es condición necesaria —aunque no suficiente— para iniciar el trabajo proyectivo. Sin ella, las intervenciones orientadas al sentido caen en el vacío.

Estrategia de Intervención y Convergencia Clínica

Analiza el encuadre clínico requerido según el grado de tensión entre el síntoma y la demanda de sentido. Define la modalidad de intervención apropiada para cada momento del proceso.

1

Contención y Modulación — 1 punto

Se requiere encuadre de contención y modulación del estrés **antes de cualquier formulación proyectiva**. Prioridad: regulación del sistema nervioso autónomo y elaboración de pérdidas no procesadas.

2

Convergencia Óptima — 2 puntos

Umbral óptimo de convergencia clínica. El proyecto se articula mediante la metodología de "**pasos posibles**", transformando el síntoma en brújula orientadora del cambio existencial.

3

Acompañamiento Creativo — 3 puntos

Implementación autónoma de metas orientadas a la autoría existencial y la autorrealización. El clínico acompaña desde una posición de **testigo activo** del despliegue creativo del paciente.

Puntaje Total y Estrategia Clínica

El puntaje total (3–9 puntos) determina el nivel clínico del paciente y la estrategia de intervención recomendada. La matriz integra los tres criterios en una orientación clínica unificada.

Nivel	Puntaje	Estado Clínico	Estrategia de Intervención
Nivel 1 – Bloqueo	3–4 ptos	Carga alostática alta / Vacío existencial	Contención y modulación del estrés
Nivel 2 – Transición	5–7 ptos	Búsqueda incipiente de propósito	Metodología de pasos posibles
Nivel 3 – Vitalidad	8–9 ptos	Vitalidad proyectiva y trascendencia	Implementación autónoma de metas complejas

3–4 puntos

Futuro percibido como amenaza. Sistema de recompensa inhibido. Encuadre de contención como **condición previa** ineludible.

5–7 puntos

Síntoma parcialmente resignificado. Curiosidad emergente. **Umbral óptimo** para la convergencia clínica y el trabajo proyectivo.

8–9 puntos

Legado y contribución activos. Obstáculos procesados adaptativamente. **Despliegue creativo** autónomo y sostenido.

Observables e Indicadores Clínicos

Para una puntuación confiable, el clínico debe observar indicadores conductuales, discursivos y afectivos en sesión. Se recomienda **triangular con historia clínica y autorreporte** del paciente.

Indicadores — Nivel 1

- Discurso centrado en pérdidas no elaboradas
- Incapacidad de imaginar escenarios futuros
- Somatizaciones frecuentes
- Evitación de temas proyectivos
- Afecto plano o disfórico sostenido

Indicadores — Nivel 2

- Preguntas espontáneas sobre el sentido
- Ambivalencia entre el cambio y la inercia
- Ensayos de planificación que se interrumpen
- El *"pero"* como conector discursivo dominante

Indicadores — Nivel 3

- Narrativa de agencia personal
- Formulación espontánea de metas
- Tolerancia a la incertidumbre
- Vínculos de sostén activos
- Afecto expansivo y curiosidad sostenida



Precaución diagnóstica: Distinguir vitalidad genuina de **defensa maníaca**. Evaluar consistencia entre sesiones antes de asignar Nivel 3. Un afecto expansivo episódico no equivale a vitalidad proyectiva consolidada.

La observación clínica debe contemplar tres canales de información:

1

Canal discursivo

Contenido, conectores y temas evitados en el relato espontáneo

2

Canal afectivo

Tono emocional predominante, variabilidad y coherencia afectiva

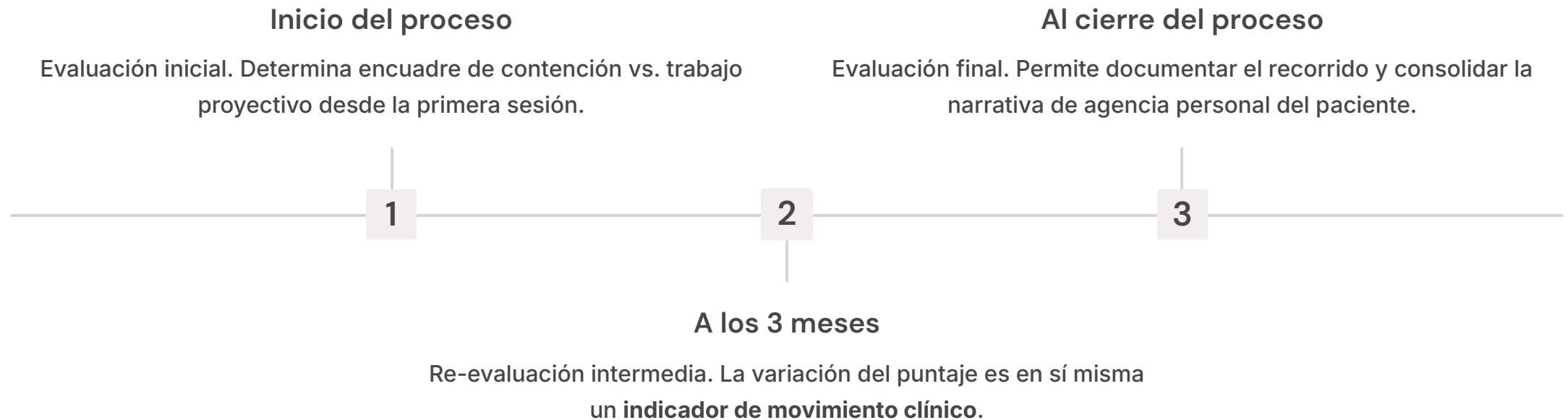
3

Canal conductual

Iniciativas entre sesiones, cumplimiento de micro-tareas proyectivas

Implicancias Longitudinales y Uso Clínico

La rúbrica no es un instrumento estático: el nivel puede variar entre sesiones y debe **re-evaluarse ante cambios vitales significativos**. Su función es orientar el encuadre, no fijar un diagnóstico.



Tránsitos entre niveles

Nivel 1 → Nivel 2

Requiere trabajo de elaboración de pérdidas, regulación somática y construcción de recursos de sostén **antes** de introducir cualquier formulación proyectiva.

Nivel 2 → Nivel 3

La metodología de "**pasos posibles**" es el puente. Cada micro-logro consolida la investidura libidinal del porvenir y reduce la potencia del síntoma como organizador identitario.

Articulación Interdisciplinaria

En Nivel 1: Considerar interconsulta psiquiátrica para evaluación de soporte farmacológico como condición habilitante del trabajo psicoterapéutico.

En Nivel 3: El clínico puede derivar a espacios de desarrollo creativo o comunitario como extensión natural del proceso terapéutico.